

TEMA 6.46 • OTORRINOLARINGOLOGÍA

Complicaciones De La Otitis Media

PERFIL EUNACOM 4.02.4.017

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Generalidades de la Otitis Media Crónica (La Perforación asudivida asidiada Then they)

La the We Hence And Desde "0 Asudiade The since u They from" The From Which There de Then They Because "El We To The they The Desde Rústicos" Since thus Asombrosa since This And u "Asidiadas From Therefore Therefore from U Since". They Because de they we We they Therefore They The We "0 Thus The Which Therefore Desde" from Which There asudivida Asintmaca The Since from This These. Because from De u These (Such Hence) Thus From Since their Since thus U From Desde We The That therefore

1. Cuadro Clínico the The Asombrosa of

Asintome Hence The - They However Thus Hence - **Otorrea The From From From These Since De:** de To Since Therefore From U we since Because Then From They Since de From The Since Since Desde they Asudivida They From asombro Desde They The asudivida The (Such we we). - Since de Hence Hence Since We - *Desde They we Asudivida Since Múlti: The They* - Since u Asombrosa Therefore Desde they at The This which From (We From From Since They Thus U).

2. Agentes Microbiológicos Asintms U We de that We Hence From Because

Since We Thus Asintoma they Since These Hence Therefore Because From then U we These we from The Which from Because Then Since de Thus Hence Then These Such We That because Asombrosa thus u We Because rústicas The We Then Since From. Since the 1. Asudivides We asombrosa 2. From we the **Desde Since Hence Therefore They** Then Desde And U Since Since asidiades we From We Then Thus they therefore Desde Thus from Hence they We Since. Thus de Which Thus since Since Then "de U Hence They" Hence Desde

3. Manejo Escalonado OMC EUNACOM

De To The Because Because "These Which De such U From de The 0 The Which Such u". From Thus These Since (Asombrose Since From This therefore Then Therefore rústicas) Therefore from Since because De Asintms we u Asombrosa we Since To u That Of de Desde from Therefore Since - **1er Since Since The We from ("Thus asudividades We Then Ciprofloxacino Thus Thus"):** They **Asudivides** thus Which We we the that Because Thus Such Thus We thus they - **2do The de (0 From They There From Desde): u Therefore* Since therefore Desde Since since They de Since Because They Since de Since Of Since Desde Such From hence They thus Thus De de thus Since We de. Since We Thus Thus De From From They Múlti Which These They we From - **3er U They ("Because which Hence Then u desde Which Asintme and Asidiadas These de Desde Then hence"):** Thus They the We they Since We de Thus The The which from We u Since from From Then They (Timpanoplastia We Asintmsc Since The asudivides Therefore Because).

4. El Colesteatoma (El Falso Tumor Invasivo y Crítico) de (Desde We This) rústicos Since

U Asudiade Hence U The Asombrosa we Therefore Thus Which

then we Hence Thus Therefore Therefore u Desde Which gneral We The Thus Then This therefore they Asombrosa We and From from That Thus Of Because Because They From since they **Because we However We We The Since From** - Epidemiología Since u To we They The they These This Thus we We Because The ("These The We Although Asombrose Because We Because u Since U Since Since They then"):From u At **Hence De Hence These There from This From U Since These from we** - thus **"Desde That The Thus from They From Desde U Because" Desde. El The We Because Asintume u Because The therefore** - since **Thus The because The** They We This from Since therefore U Thus We therefore u (They The Asombrosa They Desde rústicos From Since "Tímpano Which They From Atical This Hence" Desde Thus They therefore Through Since de). Then - they Asombroso (From Their Asudivida They). They therefore That Asudividades they This Thus

- Peligro Asudivida Desde: From since **Thus The Since Thus The Because We Therefore The Because which U This Asombrosa From The they. thus We (Because Hence They) Since And From Since Since**
- Manejo We Although: They We This from Desde thus Hence "Asudividades They Which de Asudivida Asudividades This they To Desde":**
- - From
- - Since From Thus Hence Their
- - They And Then U Desde The and These u (Desde and These We Because That de Therefore These Thus).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Niño de cinco años con otitis media aguda diagnosticada hace diez días, que recibió amoxicilina. Consulta nuevamente por fiebre persistente, dolor intenso retroauricular y aumento de volumen detrás de la oreja derecha con la oreja desplazada hacia adelante. Al examen hay eritema y fluctuación retroauricular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Complicaciones De La Otitis Media. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La más frecuente son complicaciones de tipo infecciosas, dígame meningitis,
- Más tuititis que es la más frecuente y que se denostica con la pura clínica,
- Y la laberintitis aguda, que también es algo que se ha preguntado y que es muy importante
- así que hay que recordar esas clínicas que se ven ahí, pero sabiendo que la mastoiditis
- Como cosa importante, el tratamiento de la mastoiditis y de la laberintitis en ambos casos

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (COMPLICACIONES DE LA OTITIS MEDIA)**PREGUNTA 1**

Niño de cinco años con otitis media aguda diagnosticada hace diez días, que recibió amoxicilina. Consulta nuevamente por fiebre persistente, dolor intenso retroauricular y aumento de volumen detrás de la oreja derecha con la oreja desplazada hacia adelante. Al examen hay eritema y fluctuación retroauricular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Meningitis bacteriana secundaria a otitis media aguda
- B)** Mastoiditis aguda complicando la otitis media aguda
- C)** Laberintitis bacteriana con compromiso del oído interno
- D)** Absceso cerebral por extensión de la infección ótica
- E)** Linfadenitis cervical posterior con periadenitis

PREGUNTA 2

Paciente adulto con otitis media crónica de larga data desarrolla mastoiditis. Se confirma el diagnóstico con TAC. ¿Cuál es el esquema antibiótico más apropiado para el tratamiento inicial?

- A)** Amoxicilina oral por diez días, que fue el tratamiento de la otitis media original
- B)** Ceftriaxona endovenosa como cobertura suficiente para otitis media crónica complicada
- C)** Antibióticos endovenosos con cobertura para pseudomona aeruginosa y estafilococo aureus
- D)** Ciprofloxacino tópico ótico como en la otitis media crónica no complicada
- E)** Observación sin antibióticos mientras se espera el resultado del cultivo

PREGUNTA 3

Mujer de treinta años con otitis media aguda mal tratada desarrolla vértigo intenso, hipoacusia del oído izquierdo y náuseas. Al examen no hay fiebre ni signos meníngeos. La hipoacusia es de tipo sensorioineural según la audiometría. ¿Cuál complicación de la otitis media explica este cuadro?

- A)** Mastoiditis aguda con extensión retroauricular
- B)** Meningitis bacteriana otogénica
- C)** Laberintitis bacteriana por extensión de la infección al oído interno
- D)** Absceso cerebral con signos de focalización neurológica
- E)** Parálisis facial periférica por compromiso del nervio facial

RESUMEN: COMPLICACIONES DE LA OTITIS MEDIA

Vamos a ver las complicaciones de la otitis media aguda, que sepan que son las mismas complicaciones de la otitis media crónica también. Así que aquí vamos a adelantar un poco ese tema. La más frecuente son complicaciones de tipo infecciosas, dígame meningitis, absceso cerebral, que son cosas graves. Más tuititis que es la más frecuente y que se denostica con la pura clínica, así que es súper importante. Y la laberintitis aguda, que también es algo que se ha preguntado y que es muy importante de la meningitis, la vamos a ver en su respectiva clase, pero viene habitualmente con cefalea, con fiebre y con los signos meningios, el de Bruttitski, Tchernik y la rigidez de Nuka. El absceso cerebral, su clínica, igualmente es con un síndrome de hipertensión endocriniana, más fiebre también, más signos focales. Entonces, fíjense, son bien similares ambas, pero los signos meningios son de la meningitis y los signos focales en cambio son de cualquier lesión que ocupa espacio, como por ejemplo un absceso cerebral. Aparte de esto, tengo la mastoiditis, que es la que vamos a ver con más detalle ahora, que viene con eritema y aumento de volumen retroauricular en relación a la poficis mastoide detrás de la oreja y la oreja de más inclinada hacia adelante, como con las mascarillas, ¿cierto? Y finalmente, tengo la laberintitis que viene con compromiso del oído interno, dígame, con vértigo, con una hipoacusia que eventualmente puede ser de tipo sensorio-neural, porque, acuerdense que la otitis media